

- **Anamnèse actuelle :**

Un nourrisson de 6 semaines, en bonne santé jusqu'à présent, est amené aux urgences de pédiatrie pour des vomissements depuis 5 jours. Il présente à plusieurs reprises pendant la journée des vomissements en jet de lait caillé. Il est affamé et tète vigoureusement à chaque fois qu'il est mis au sein. Il est afebrile, ne présente pas de diarrhée et son poids est resté stable depuis 5 jours.

- **Examen physique :**

Nourrisson de sexe masculin, en état général légèrement réduit mais état nutritionnel encore conservé. Pleure vigoureusement et a faim

Température : 37,0°C, FC : 120/min, TA : 75/55 mm Hg.

Examen ORL calme, signe du pli cutané légèrement positif, fontanelle antérieure à niveau.

FR : 32/min, murmures vésiculaires symétriques, pas de bruits surajoutés.

Auscultation cardiaque physiologique.

Abdomen souple, indolore, foie à 1 cm du rebord costal, rate non palpable, bruits abdominaux physiologiques. Toucher rectal s.p.

Organes génitaux externes masculins, s.p.

Examen neurologique s.p.

P 004071

Session:	Quickstart	Catalog
Question type:	Options:	
Single Choice	True	4

- Quel est le diagnostic le plus probable ? (question type A)
- A. Volvulus sur malrotation
- B. Méningite
- C. Sténose hypertrophique du pylore
- D. Atrésie duodénale
- E. Orchi-épidymite

- Quel examen(s) complémentaire(s) est/sont le plus indiqué en cas de sténose hypertrophique du pylore ?(question type K')
- A. Dosage de la glycémie
- B. Dosage amylase, lipase
- C. Gazométrie/ gaz sanguins
- D. Dosage électrolytes

- Quel examen d'imagerie médicale est indiqué et permet de confirmer le diagnostic de sténose hypertrophique du pylore ? (question type A)
- A. Ultrason /échographie de l'abdomen
- B. Radiographie (Rx) abdomen
- C. CT scan abdomen/abdominal
- D. IRM/MRI abdomen/abdominal
- E. Radiographie (Rx) thorax

- **Anamnèse :**

Vous voyez un nourrisson de 5 semaines de vie, amené pour une cyanose des lèvres lors des pleurs.

La grossesse, l'accouchement et la période néonatale se sont passées sans particularités.

- **Examen physique :**

- Nourrisson de 5 semaines de vie en état général conservé, afébrile, FC : 110/min, TA : 85/55 mm Hg. Il présente une cyanose généralisée lors des pleurs.
- Auscultation cardiaque : souffle systolique râpeux de grade 3 à 4/6 au niveau du bord sternal supérieur gauche.
- Auscultation pulmonaire : murmures vésiculaires symétriques, pas de tachypnée, pas de signe de détresse respiratoire, pas de signes d'obstruction.
- Reste de l'examen physique sans particularités.

- Quel est le diagnostic le plus probable ? (question type A)
- A. Communication inter-ventriculaire
- B. Transposition des grands vaisseaux
- C. Tétralogie de Fallot
- D. Coarctation de l'aorte
- E. Sténose mitrale

- Quel examen(s) complémentaire(s) est/sont le plus indiqué en cas de tétralogie de Fallot ? (question K')
- A. Electrocardiogramme (ECG)
- B. CT scan thorax
- C. Ultrason/échographie cardiaque transthoracique
- D. Radiographie (Rx) thorax

- Quel sont les médicaments qui sont indiqués lors d'un épisode de cyanose soudaine et importante (crise hypercyanotique) ?
(question K')
- A. Oxygène
- B. Bêtabloqueur (propanolol)
- C. Morphine
- D. Bolus de 20 ml/kg NaCl 0.9%

- Nora a 10 ans, elle est connue pour une drépanocytose diagnostiquée peu après sa naissance. Elle reçoit un traitement d'hydroxyurée . Elle se présente aux urgences avec un état fébrile à 38.5 ° et des douleurs osseuses dans le bras gauche et la jambe droite. Elle a reçu un traitement antalgique avec du paracétamol et des AINS à la maison.
- Quelles seront vos axes de prise en charge ? (question K`)
 - A) commencer une hyperhydratation avec du NaCl 0.9%
 - B) prélever une hémoculture et commencer un traitement de ceftriaxone
 - C) stopper l'AINS car ce traitement pourrait péjorer son anémie hémolytique
 - D) proposer un traitement de fentanyl intra-nasal

- Nora a 10 ans, elle est connue pour une drépanocytose diagnostiquée peu après sa naissance. Elle reçoit un traitement d'hydroxyurée dont le dosage a été récemment augmenté. Elle a décidé de commencer un régime végétarien depuis quelques mois. Elle se présente aux urgences 4 semaines après sa précédente consultation avec un état fébrile à 38.2° , une fatigue importante et une éruption cutanée maculo-papulaire sur le tronc, les membres et les joues. Elle est sous un traitement d'acide nalidixique depuis 5 jours pour une infection urinaire à E Coli sensible. Son hémoglobine habituelle est autour de 85 g/L mais vous effectuez un contrôle qui est ce jour à 65 g/L.
- Quelle est la cause probable de cette péjoration de son anémie? (type A)
 - A) une crise hémolytique sur l'acide nalidixique
 - B) une intolérance à l'hydroxyurée secondaire à l'augmentation du traitement
 - C) une crise aplastique sur une infection à parvovirus
 - D) une crise sur une sequestration splénique
 - E) un déficit de fer secondaire à son régime

P 804271		
Session	Question	Catégorie
Question type	Options	
Multiple Choice	A	

Un garçon de 10 ans est amené en consultation par son pédiatre car il a des difficultés scolaires depuis 8 mois. Ses enseignants se plaignent qu'il n'écoute par leur instruction, qu'il parle souvent en classe et finit rarement les tâches qu'on lui donne à faire. Il se lève sans cesse de sa chaise et dépasse tout le monde dans la queue du restaurant scolaire. A la maison, il court sans cesse. Il interrompt souvent les conversations en famille et parle sans cesse. Il grimpe souvent et elle a peur quand il part à l'école à vélo car il ne s'arrête pas toujours devant les stops sur la route et traverse sans regarder. Son examen physique est sans particularité, y compris un examen neurologique soigné. Son status mental est dans la norme et ne montre pas de trouble de l'affect.

Quel est le diagnostic le plus probable ?

- 1) Spectre autistique
- 2) Comportement approprié pour l'âge
- 3) Trouble d'apprentissage spécifique (dyslexie, dyscalculie)
- 4) Syndrome dépressif
- 5) Déficit d'attention avec hyperactivité

P 804671

Session : Quizzstart

Question type: Q

Single Choice

Le diagnostic de déficit d'attention avec hyperactivité est posé après un entretien et un questionnaire ciblé.

Quelle prise en charge est recommandée ? (type K'):

- 1) Appareil auditif
- 2) Psychothérapie comportementale
- 3) Fluoxetine
- 4) Métylphénidate

- Un bébé de 20 jours est amené aux urgences par ses parents. Il est fébrile à 38.4°C , il ne présente pas de toux, diarrhée, il a vomi à une reprise et pleure un peu plus que d'habitude, il mange moins bien. A l'examen physique, il est légèrement marbré en périphérie, le temps recoloration capillaire est inférieur à 3 secondes, le reste de l'examen physique est sans particularité.
Quelle prise en charge est indiquée ?
- A. Hémoculture, analyse et culture de LCR, examens d'urine
 - B. Hémoculture et examens d'urine
 - C. Procalcitonine, CRP, hémoculture et selon les résultats des marqueurs: analyse et culture de LCR
 - D. Hospitalisé le bébé avec une surveillance clinique sans examen complémentaire
 - E. Retour à domicile et surveillance clinique une fois par jour

- Voici les examens complémentaires pour ce bébé :
 - Procalcitonine : 0.4 CRP : 10 pas de leucocyturie, LCR : 1 leucocyte, hémoculture et culture de LCR en cours
 - Quelle est le traitement indiqué ?
- A. Amoxicilline et gentamicine
 - B. Ceftriaxone et gentamicine
 - C. Ceftriaxone
 - D. Ciprofloxacin
 - E. Pas de traitement antibiotique d'emblée

- Un bébé de quatre mois arrive à votre consultation de pédiatrie pour un contrôle de santé. Il est né à terme par voie basse et n'a pas présenté de problème de santé. Il est complètement allaité et reçoit la vitamine D, ses vaccinations sont à jour. La maman a entendu parler de la mort subite du nourrisson et elle aimerait des conseils à ce sujet. Quelle est la recommandation la plus importante pour prévenir cette condition ?

- 1) Faire dormir le bébé dans le lit de ses parents
- 2) Faire dormir le bébé sur le dos
- 3) s'assurer qu'il n'y a pas de fumeurs dans la maison
- 4) éviter l'utilisation de lolette/sucette/ pacifier
- 5) Utiliser une couette pour que le bébé n'ait pas froid

Un nourrisson de 10 mois est admis à l'hôpital suite à l'apparition progressive d'un état fébrile, une toux rauque, un stridor inspiratoire et d'une discrète détresse respiratoire. Quel est l'agent infectieux probablement en cause ?

1. Adénovirus
2. Virus respiratoire syncycial
3. Virus parainfluenza
4. Haemophilus influenzae
5. Corynebacterium diphtheriae

P 804671

Session Quickstart Catalog

Question type: Options

Single Choice 1 5

Ce nourrisson souffre d'un faux-croup et il a une augmentation de fréquence respiratoire avec un important tirage intercostal et un stridor audible au repos ainsi qu'une diminution de l'entrée d'air à l'auscultation.

Quelle est la prise en charge indiquée ?

1. Un train de 3 fois 6 push de Ventolin/salbutamol avec une chambre d'inhalation
2. Une physiothérapie respiratoire
3. Un aérosol d'adrénaline
4. 2 push de buténoside (corticoïde topique) avec une chambre d'inhalation
5. Une antibiothérapie par amoxicilline

P 804871

Session	Question	Catalog
Question type:	Options:	
Single Choice	5	

Anna, un nouveau-né de 3500 gr, elle est née à 39 semaines après une grossesse avec un suivi sans particularité. La maman n'a pas fumé, n'a pas bu de l'alcool et a pris ses vitamines. Anna a eu un Apgar à 8 à 1 minutes et 9 à 5 minutes. Sa température est à 37 ° C, son pouls à 120/min et sa TA à 55/35 mmHg. A son examen physique, le pédiatre remarque une clitoromégalie. Les examens complémentaires à 24 heures de vie montrent :

Hb : 15.8 g/dL Na : 133mEq/L, K: 5.2 mEq/L Cl: 101 mEq/L, fonction rénale : normale

Un ultrason des ovaires et de l'utérus est normal

Quel est la prise en charge indiquée ?

- 1. Chirurgie reconstructive des organes génitaux
- 2. Conseils aux parents vers un changement de sexe de l'enfant
- 3. Traitement de substitution avec des œstrogènes
- 4. Traitement d'hydrocortisone et de fludrocortisone

Un garçon de 8 ans est amené par sa maman chez son pédiatre. Elle est inquiète car son garçon présente des épisodes pendant la journée où il paraît rêver pendant de courts instants. Il a des difficultés scolaires depuis quelques semaines. Il a un développement psycho-moteur normal. Il a eu un enregistrement EEG qui montre des décharges bilatérales de pointes-ondes à une fréquence de 3 Hz qui commencent et s'arrêtent de manière abrupte sur un tracé par ailleurs normal.

Quel est le diagnostic de présomption ?

- A. Épilepsie absence
- B. Crises d'épilepsie partielle avec trouble de la conscience
- C. Syndrome d'hyperactivité avec trouble d'attention
- D. Crises d'épilepsie partielle sans altération de la conscience
- E. Crise d'épilepsie tonico-clonique (grand Mal)

P 80421

Session: Quizzstat Caté

Question type: Options

Multiple Choice v 4

- Une petite fille de 16 mois est amenée aux urgences car elle est irritable, elle refuse de se nourrir et a 39.4 °C de température. L'anamnèse et l'examen physique ne mettent pas en évidence de cause identifiable à cette fièvre. Il y a seulement une légère douleur abdominale à la palpation profonde.
- Quel est l'étape suivante de la prise en charge la plus appropriée ?
 - 1) radiographie de l'abdomen
 - 2) stix +/- culture urinaire après sondage urinaire
 - 3) recherche de leucocytes dans les selles et coproculture
 - 4) Ultrason rénal
 - 5) Cysto-urétrographie mictionnelle

P 004071

Session: Quizzat Catalogue

Question type: Options

Multiple Choice 4

- Un bébé naît à 37 semaines de gestation après 72 heures de rupture des membranes. Le score d'Apgar est à 4 à 5 minutes. Il présente une détresse respiratoire. Une hémoculture pousse après 12 heures de culture et le laboratoire vous appelle pour vous signaler qu'il s'agit de cocci (coques) Gram positif en chaînettes.

Lequel des germes suivants est le plus probable?

1. Streptococcus du groupe A
2. Streptococcus du groupe B
3. Staphylococcus aureus Méthicilline-résistant
4. Staphylococcus aureus sensible à la Méthicilline
5. Neisseria meningitidis

P 804671

Session: QuickRef Catalogue

Question type: Options

Single Choice 1/1 5

- Un garçon de 6 ans a de multiples lésions sur sa face et ses avant-bras Il a 37.9 °C de température. Il n'y a rien d'autre à l'examen physique.
- Quel est le traitement le plus approprié ?
 - 1) Clarithromycin
 - 2) flucloxacillin
 - 3) Pénicilline G
 - 4) Pénicilline V
 - 5) Vancomycine



- Un enfant de 11 mois est amené aux urgences par ses parents. Cet enfant a une fracture du fémur droit. Le père raconte qu'il est tombé de son lit à barreaux. Cet enfant a des hématomes sur les épaules et sur son dos. Le reste de son examen clinique est normal. Les orthopédistes proposent traitement conservateur avec confection d'un plâtre.
- Quelle est l'étape suivante de sa prise en charge la plus appropriée ?
 - 1) Plâtre pelvi cruro-pédieux et retour à domicile
 - 2) Radiographie du thorax
 - 3) CT-scan cérébral
 - 4) Fond d'oeil
 - 5) Ponction lombaire

- Une fillette de 7 ans est amenée chez son pédiatre pour un contrôle. A l'examen physique, le pédiatre note le développement de tissu mammaire. Elle a une pilosité débutante sur le pubis. Sa taille et son poids sont au percentile 80.
- Quelle est l'étape suivante de sa prise en charge la plus appropriée ?
- 1) CT-scan cérébral et abdominal
- 2) ultrason du petit bassin
- 3) radiographie du poignet
- 4) rassurer les parents et suivre cliniquement
- 5) mesurer la TSH

- Une fille de 14 ans consulte son pédiatre car elle se plaint de douleur et de tuméfaction de son genou gauche depuis 43 jours. Elle joue du football régulièrement et elle a dû arrêter de s'entraîner à cause de la douleur. Elle n'a pas eu d'accident. A l'examen physique, il y a un œdème marqué avec une douleur en face de la tubérosité tibiale. Une radiographie montre une fragmentation de la tubérosité tibiale antérieure.
- Quel est votre diagnostic de présomption?

- 1) Chondromalacie patellaire
- 2) Sarcome d'Ewing
- 3) Douleur de croissance
- 4) maladie de Legg-Calvé Perthes
- 5) Maladie de d'Osgood-Schlatter

P 804571

Session	Quickstart	Ca
Question type	Opt	
Single Choice	→	5

- Un petit garçon de 4 ans en bonne santé habituelle se plaint de douleur dans ses deux jambes depuis 3 semaines. A l'examen physique, sa température est à 37.8°C. A l'examen physique, on note une pâleur marquée de ses lèvres et de ses conjonctives. Il y a des pétéchies sur sa peau et on palpe une rate à 3 cm du rebord costal. Il n'y a pas de limitation de la mobilité des articulations, ni de tuméfaction des articulations. Une formule sanguine complète révèle des globules blancs: 1,6 G/L une Hb: 69 g/L et des plaquettes: 36 G/L
- Quel est le diagnostic de présomption?
 - 1) leucémie aigüe lymphocytaire
 - 2) Sarcome d'Ewing
 - 3) Douleur de croissance
 - 4) arthrite septique
 - 5) arthrite juvénile idiopathique

P 304571

Session	Quel statut	Catégorie
Question type:	Options	
Single Choice	7/10	5

Durant le change des couches d'un nouveau-né, la sage-femme note des plis fessiers asymétriques. Ce nouveau-né a trois jours de vie et est né par césarienne pour non –progression de l'accouchement, il est en bonne santé depuis la naissance. Sa température est de 37.2°C, son pouls est à 125/min et sa fréquence respiratoire à 50 par minute. Il pèse 3.2 kg. A l'examen physique, on remarque que la hanche gauche est facilement luxable postérieurement avec un ressaut et un clic. On entend un craquement quand elle retourne à sa position normale. La mère est inquiète car elle a pris de la tétracycline au début de sa grossesse.

Quel examen suivant va apporter le diagnostic le plus probable ?

- 1) Scintigraphie osseuse
- 2) CT-scan
- 3) Radiographie de la hanche avec incidence de Lowenstein
- 5) Taux de tétracycline
- 6) échographie

P 804571

Session Quickstart Cal

Question type: Opti

Single Choice 5

- Un nouveau-né à terme est examiné après une naissance par siège. A l'examen neurologique, on remarque un réflexe de Moro asymétrique avec le bras gauche qui ne bouge pas. Quand on soulève le bras gauche, il retombe le long du corps. En position de repos, le bras reste en adduction, rotation interne avec l'avant-bras en pronation. Le réflexe de grasping de la main est normal des deux côtés. Le reste de l'examen physique est normal.
- Quel est le diagnostic de présomption ?
 - 1) fracture de la clavicule
 - 2) Paralysie d'Erb
 - 3) Lésion de la moelle épinière
 - 4) Hématome sous-dural
 - 5) Leucomalacie péri-ventriculaire



P 804671

Session Quick

Question type:

Single Choice

- Une jeune fille de 12 ans se plaint de palpitations. Elle est en bonne santé et il n'y a pas d'histoire de maladie cardiaque dans la famille. Elle ne prend ni médicament, ni drogue. Elle raconte que les palpitations commencent et s'arrêtent soudainement et durent quelques heures. Elle est asymptomatique entre les intervalles. L'examen physique est normal. Vous faites un ECG
- Quel est le diagnostic le plus probable?
- 1) crise d'angoisse
- 2) tachycardie sinusale
- 3) syndrome de syndrome génétique de QT-long
- 4) syndrome de Wolf-Parkinson -White
- 5) tachycardie ventriculaire

P 804071

Session QuizStart

Question type:

Single Choice

- Une fille de 12 ans se présente avec des pertes vaginales depuis deux mois. Les pertes sont blanches mais tachent ses sous-vêtements. Elle dit qu'elle hait les garçons et qu'elle n'a jamais eu de relations sexuelles. Elle a des seins qui se développent depuis 2 ans. L'examen du périnée montre une pilosité de stade Tanner III sans rougeur du périnée ni irritation vulvo-vaginale. Une petite quantité de mucus sans odeur est observée.
- Quelle est l'étape suivante la plus appropriée ?
 - 1) Pas de traitement
 - 2) Examen du petit bassin avec culture pour les gonorrhées et le Chlamydia
 - 3) metronidazole gel en application locale
 - 4) Bain de siège et application de crème à l'hydrocortisone 1% une fois par jour pendant une semaine
 - 5) Culture à la recherche de Candida

P 004121

Session Quickstart Data

Question type Options

Single Choice 5

- Une fillette de 10 ans a eu un accident de la circulation avec de multiples blessures à la tête, aux bras et à l'abdomen. Sa tension artérielle est à 90/60 mm Hg et sa fréquence cardiaque à 120/minute. Son avant-bras est déformé et on peut voir un fragment d'os à travers la plaie. Son abdomen est rigide et douloureux.
- Quelle est l'étape suivante la plus appropriée ?
 - 1) Immobiliser le bras et le recouvrir de gaze stérile.
 - 2) Administrer une solution cristalloïde
 - 3) Administrer un traitement vaso-presseur
 - 4) Transfuser du sang
 - 5) Effectuer un CT-scan abdominal

Un nourrisson de 3 semaines de vie est amené aux urgences en raison d'un état fébrile à 38.9°C. IL est né à terme par voie basse, d'une grossesse sans particularité. L'enfant est hospitalisé après l'obtention de cultures d'urine, sang et LCR. Le LCR était trouble.

Quelle est la complication la plus fréquente que peut présenter cet enfant?

1. Déficit visuel
2. Abscès cérébral
3. Kernicterus
4. Quadriplégie
5. Déficit auditif

P 804671

Session	Quickstart	Catalog
Tag:		Duration
All Tags	▼	30s

Un enfant de 10 mois est amené aux urgences en raison de vomissements biliaires depuis 6 heures ainsi que de douleurs abdominales intermittentes accompagnées de pleurs intenses. La maman a remarqué la présence d'une substance ressemblant à de la gelée de groseille dans la couche.

A l'examen clinique, vous palpez une masse dans le quadrant inférieur droit de l'abdomen.

Le diagnostic le plus probable chez cet enfant est:

1. Une sténose du pylore
2. Un volvulus intestinal
3. Une invagination iléo-colique
4. Une entérocolite nécrosante
5. Une pyélonéphrite aiguë

P SCALTT

Settings: Quickstart Catalogue

Question type: Options:

Single Choice 5

Save

Vous êtes appelé pour évaluer un nourrisson de 4 mois avec constipation chronique. A l'examen, l'enfant est en bon état général, son abdomen est distendu, il n'y a pas de sang ou selles dans l'ampoule rectale. A l'anamnèse on note que le bébé a émis du méconium au quatrième jour. D'après les informations ci-dessus, quel diagnostic est le plus probable chez cet enfant?

1. Botulisme
2. Constipation fonctionnelle
3. Fistule rectale
4. Maladie de Hirschprung (mégacolon congénital)
5. Syndrome de moelle bas insérée

P 804671

Session Quickstart Catalogue

Question type: Options:

Single Choice 5

Un enfant de 3 ans se présente à votre consultation avec ses parents. Ils sont inquiets car il a une énurésie nocturne. Alors qu'il est propre de jour depuis environ 6 mois, il continue à mouiller son lit chaque nuit. Il ne présente pas de symptômes urinaires comme une dysurie ou des urgences mictionnelles. Quel est parmi les suggestions ci-dessous la meilleure prise en charge initiale de cet enfant?

1. Demander une consultation spécialisée avec un bilan urologique complet
2. Proposer l'acquisition d'un pipi-stop (alarme qui réveille l'enfant la nuit) pour traiter l'énurésie nocturne
3. Poser des questions concernant l'environnement familial de l'enfant (par exemple le stress)
4. Réassurer les parents et leur expliquer qu'il s'agit d'une situation normale dans l'acquisition de la propreté et du contrôle sphinctérien
5. Prescrire de l'oxybutynine

Vous êtes appelés à la maternité pour examiner un nouveau-né. Il présente un poids de naissance en-dessous du 5^{ème} percentile, des petites fentes palpébrales, une microcéphalie et un philtrum plat. Parmi les substances ci-dessous, quelle est celle avec laquelle la mère a été le plus probablement en contact durant sa grossesse?

1. Plomb
2. Mercure
3. Alcool
4. Benzène
5. Monoxyde de carbone



Une jeune fille de 16 ans vient à votre consultation et se plaint d'une toux principalement nocturne, sans sécrétion de mucus et d'une dyspnée depuis 3 semaines. Elle nie la présence de fièvre ou de douleurs. Néanmoins, elle a éprouvé des symptômes semblables de moindre intensité il y a un an, également au printemps.

Pour confirmer la suspicion diagnostique qui s'impose, quel examen est le plus approprié?

1. une bronchoscopie
2. une spirométrie
3. une radiographie du thorax
4. un test d'effort
5. une formule sanguine complète





Une jeune fille de 15 ans se présente avec une éruption par plaque rouge et desquamante sur le nez et les joues. Elle a également des lésions érythémateuses et desquamantes sur la face dorsale des doigts. Les valeurs de laboratoire révèlent une anémie et une protéinurie (photos).

Le diagnostic le plus probable est:

1. Dermatomyosite
2. Arthrite juvénile idiopathique
3. Eczéma atopique
4. Réaction médicamenteuse
5. Lupus érythémateux disséminé

***Table 1. Critères d'inquiétude**

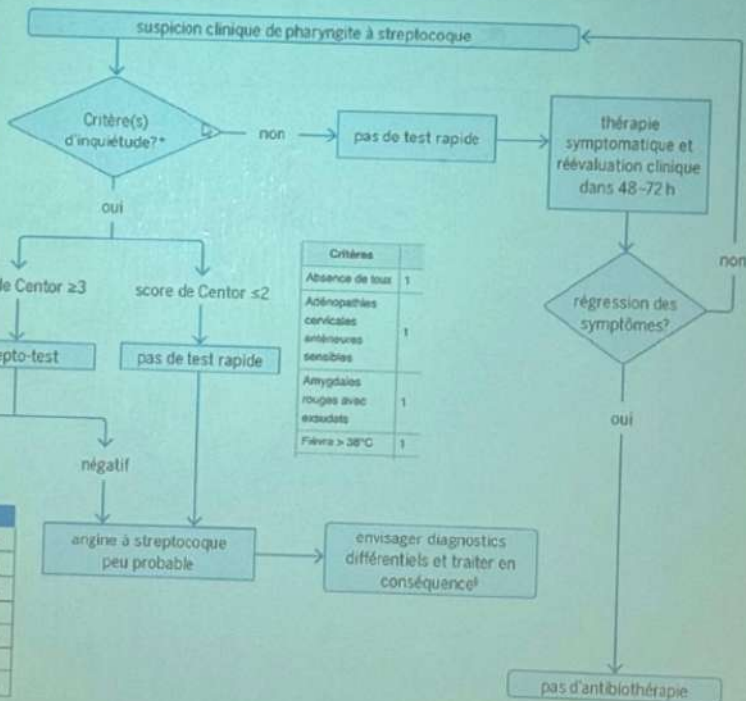
Signes d'alerte clinique

- Mauvais état général
- Suspicion d'abcès périamygdalien/rétropharyngé

Risque augmenté de complications

- Immunosuppression
- Antécédents personnels ou familiaux de RAA*
- Patient ayant récemment immigré d'un pays en développement
- Valvulopathie cardiaque avec risque d'endocardite

* test rapide justifié quel que soit le score de Centor



Critères	
Absence de toux	1
Adénopathies cervicales antérieures sensibles	1
Amygdales rouges avec exsudats	1
Févre > 38°C	1

****Antibiothérapie pour l'angine à streptocoques**

	Posologie	fréquence	durée
Amoxicilline	25 mg/kg/dose	2x/jour	6 jours
Pénicilline	50 000 UI/kg/dose	2x/jour	10 jours
alternative en cas d'allergie non sévère à la pénicilline			
Cefuroxime	15 mg/kg/dose	2x/jour	6 jours
contre-indication absolue aux bêta-lactamines			
Clindamycine	7 mg/kg/dose	3x/jour	6 jours

§ antibiothérapie à considérer dans tous les cas de mauvais état général et de suspicion de complications suppuratives

Un enfant de 6 ans se présente à votre consultation pour un état fébrile jusqu'à 39°C, des maux de gorge et des douleurs articulaires depuis 2 jours. Il n'a ni toux, ni rhume.

Deux heures avant l'arrivée aux urgences, il décrit des céphalées et des douleurs abdominales avec un épisode de vomissement. À l'examen clinique, le patient présente une hypertrophie bilatérale des amygdales avec exsudat et une lymphadénopathie cervicale antérieure bilatérale. Le reste de l'examen physique est dans la norme.

Parmi les examens ci-dessous lequel est le plus approprié dans la prise en charge initiale de ce patient?

1. Frottis de gorge pour le Streptocoque du groupe A
2. Frottis de gorge pour l'*Haemophilus influenzae*
3. Radiographie latérale du cou
4. Vitesse de sédimentation
5. Pas d'examen

Lors de l'examen médical à la fin de l'école obligatoire, vous trouvez chez une jeune fille de 16 ans, sans plaintes subjectives, une tension artérielle de 85/50 mmHg. Pour le reste, l'examen clinique est normal.

Il faut recommander à cette jeune fille:

1. consulter son médecin de famille pour une investigation
2. prendre des médicaments qui augmentent la tension artérielle
3. ne pas pratiquer de sport de compétition
4. éviter la haute altitude
5. ne pas s'en préoccuper

Une jeune fille de 15 ans se présente en salle d'accouchement à 36 semaines de gestation et raconte qu'elle a perdu les eaux il y a 4 jours. Elle présente de rares contractions utérines, le col est perméable à un doigt, et elle n'a pas eu de fièvre. Le monitoring ne met pas en évidence des signes cardiaques de stress chez le fœtus. Son médecin débute une provocation à l'ocytocine. 10 heures plus tard, elle met au monde une fillette de 3kg, dont le score d'Apgar est de 6 à 1 minute et 9 à 5 minutes.

Le facteur de risque le plus important pour une infection néonatale est:

- A. sexe féminin
- B. âge de la mère
- C. score d'Apgar à 1 minute
- D. rupture prématurée de la poche des eaux
- E. âge gestationnel <37 semaines

Dans un camp de réfugiés, vous examinez un garçon de 2 ans qui présente 3 jours de fièvre à 40°C, une toux, une rhinite et une conjonctivite. L'examen clinique révèle une photophobie, une conjonctivite, et un rash maculaire derrière les oreilles, sur le visage et le tronc.

A propos de cette maladie, tout est vrai sauf?

1. C'est une maladie mortelle
2. La contagiosité est très grande
3. Il existe un vaccin contre cette maladie
4. On la traite par antibiotique
5. Il peut y avoir des complications longtemps après

Quelques jours après la résolution d'une infection virale, un garçon de 7 ans se présente aux urgences en raison d'une marche titubante. A l'examen neurologique il présente une ataxie, une anomalie des épreuves doigt-nez et talon-genou.

Quel est le virus le plus probablement en cause?

1. Virus Herpes simplex
2. Virus varicelle-Zoster
3. Cytomégalovirus (CMV)
4. Virus d'Epstein Barr (EBV)
5. Virus Hepatite A

Un enfant de 4 ans connu pour un reflux vésico-urétéral modéré présente des infections urinaires à répétition malgré une antibioprophylaxie adéquate. Quel est la prise en charge la plus appropriée?

1. Antibiothérapie IV pendant 2 semaines
2. UIV (Urographie intraveineuse)
3. Angiographie rénale
4. Chirurgie anti-reflux
5. Ajouter de la vitamine C à la prophylaxie antibiotique

Un bébé âgé de 10 jours est amené chez vous. Il est né 15 jours avant terme avec un poids de 2500 g. Il a émis du méconium à 12 heures de vie et s'est alimenté normalement. Depuis ce matin, il présente des vomissements teintés de bile, est apathique, refuse de téter et il a une température de 36 °C. Il n'a pas été à selles depuis 12 heures. A l'examen, son abdomen est souple, mais le bébé gémit quand vous le palpez.

Quel est le diagnostic de présomption?

1. la maladie de Hirschsprung
2. une atrésie intestinale
3. une sténose hypertrophique du pylore
4. un volvulus intestinal
5. une invagination

Un garçon de 13 ans obèse souffre de douleurs à la hanche depuis 2 mois. A l'examen, on met en évidence une diminution de la rotation interne de la hanche gauche.

Quelle est la cause la plus vraisemblable?

1. une épiphysiolyse de la tête fémorale
2. une coxarthrose
3. une tumeur à cellules géantes
4. une arthrite tuberculeuse
5. une dysplasie de hanche

Une enfant de 5 ans est amenée aux urgences pour un état fébrile à 39.6°C dans un contexte de baisse de l'état général, d'irritabilité et de vomissements. Durant les 3 derniers jours elle a reçu de hautes doses d'amoxicilline en raison d'une otite bilatérale. L'examen clinique met en évidence un état fébrile à 40°C , une apparence toxique et une irritabilité. L'examen du liquide céphalo-rachidien documente un glucose diminué à 0.56 mmol/l , des protéines élevées à 1.5 gr/l , 620 globules blancs/ mm^3 avec une prédominance de polymorphonucléaires, pas de globules rouges. A l'examen direct (Gram) il n'y a pas de germes décelables.

Le diagnostic le plus probable est :

1. Méningite à enterovirus
2. Encéphalite herpétique
3. Méningite sur maladie de Lyme
4. Méningite bactérienne décapitée
5. Méningite tuberculeuse

Un enfant de 12 ans se présente au cabinet en raison de maux de gorge violents. Les jours derniers, il présentait des difficultés à avaler les solides, puis à présent une odynodysphagie aux liquides et à sa salive. Vous le suivez depuis la naissance et tous ses vaccins sont à jour. A l'examen clinique, il est fébrile à 38.9°C, l'amygdale gauche enflée, le voile du palais bombant et la luette déplacée. L'amygdale droite est normale.

Quel est le diagnostic le plus probable?

1. Gingivostomatite herpétique
2. Angine virale
3. Diphtérie
4. Abscess amygdalien
5. Pharyngite



Un garçon de 8 ans se présente avec une éruption prurigineuse aiguë sur les bras et les jambes caractérisée par des papules, des tâches et des vésicules alignées de façon linéaire. Il a déjà présenté par le passé le même type d'éruption après avoir touché une plante.

Le diagnostic le plus probable est :

1. Dermatite atopique
2. Dermatite de contact
3. Impetigo
4. Eczéma nummulaire
5. Infection à herpès zoster

Un petit garçon de 4 ans est amené chez son pédiatre car il refuse de marcher depuis qu'il s'est levé ce matin. La semaine passée, il a présenté une infection des voies aériennes supérieures. Il a joué au football la veille. Sa température est de 37.2 °C. Son status est dans la norme à part une limitation douloureuse de l'abduction et de la rotation externe de la hanche droite. Sa formule sanguine montre: leucocytes 11.2 G/l (norme: 4.5-11) avec 6 % de neutrophiles non segmentés. La CRP est à 25 mg/l (norme: <10). L'ultrasonographie de la hanche montre un épanchement intra-articulaire de faible importance.

Quel est le diagnostic le plus probable?

1. une arthrite septique
2. une maladie de Perthes
3. une arthrite chronique juvénile
4. un sarcome d'Ewing
5. une synovite transitoire de la hanche

16

Une fillette de 3 ans se présente à votre consultation. La maman vous explique qu'elle a eu de la fièvre quotidiennement depuis 7 jours, surtout la nuit. A l'examen clinique, elle a des lèvres sèches et érythémateuses, une langue framboisée, une conjonctivite bilatérale, un érythème multiforme, des adénopathies cervicales et une splénomégalie.

Un examen sanguin révèle une anémie et une leucocytose. Un strepto test rapide est négatif. Le facteur rhumatoïde, FAN, ASLO et sérologies pour la maladie de Lyme sont négatifs. La radiographie du thorax est négative.

Quel est le diagnostic le plus probable chez cet enfant?

1. Mononucléose
2. Maladie de Lyme
3. Rougeole
4. Maladie de Kawasaki
5. Scarlatine

Un nourrisson de 6 mois a depuis quelques jours une fièvre de 40 °C. Il est très irritable et sa fontanelle est tendue. La ponction lombaire pratiquée au 3e jour est normale. Au 4e jour apparaît sur le tronc un exanthème formé de petites taches rouge clair. L'enfant devenant en même temps afébrile.

Quel est le diagnostic le plus probable?

1. une rougeole
2. une rubéole
3. une roséole (exanthème subit)
4. une infection virale à Coxsackie
5. une scarlatine

Vous êtes appelé à la maternité pour évaluer un nouveau-né à terme de 6 heures de vie qui a développé une tachypnée à 100/minutes. Il présente un grunting et une rétraction sus-sternale mais pas de cyanose. L'auscultation pulmonaire est propre sans ronchis ni râles. La radiographie du thorax montre une accentuation de la trame broncho-vasculaire. La silhouette cardiaque est normale.

Lequel des diagnostics suivant est le plus probable?

1. Maladie des membranes hyalines
2. Tachypnée transitoire du nouveau-né
3. Aspiration méconiale
4. Pneumonie virale
5. Insuffisance cardiaque

Jason, âgé de 8 mois, est connu depuis la naissance pour une tétralogie de Fallot. Sa mère remarque soudain qu'il devient tout gris alors qu'elle était en salle d'attente de consultation de cardiologie. Jason est positionné en position genou-pectorale mais cela ne change rien.

Sélectionner dans la liste ci-dessous le traitement approprié de cette crise:

1. Perfusion de prostaglandines
2. Immersion du visage dans de l'eau glacée
3. Béta-bloquant intra-veineux
4. Antibiotiques intra veineux
5. Choc électrique

Un garçon de 18 mois en bon état général présente depuis quelque semaines un écoulement jaune-verdâtre, d'odeur fétide, provenant de la narine droite.

Quel est le diagnostic le plus vraisemblable?

1. une sinusite maxillaire droite
2. une sinusite ethmoïdale droite
3. un corps étranger dans la narine droite
4. une hyperplasie adénoïdienne avec adénoïdite
5. une tumeur dans la narine droite

Vous évaluez un nourrisson de 3 semaines qui présente des selles défectueuses fréquentes, mêlées à du sang ; la prise pondérale est faible ; une colite est suspectée. L'enfant est exclusivement allaité.

Que faites-vous pour déterminer une éventuelle allergie alimentaire, à l'origine de cette colite ?

1. Dosage des anticorps IgE anti-protéine bovine
2. Test cutané (prick test) avec des protéines bovines
3. Dosage des IgE totales
4. Régime sans protéine bovine chez la mère
5. Dosage des IgE anti-oeufs

Un nouveau-né de 2 jours présente depuis la naissance une détresse respiratoire s'aggravant progressivement. Il a de plus des vomissements à chaque tentative d'alimentation. Il n'a pas émis de méconium. L'anamnèse familiale et la grossesse sont sans particularité. Poids de naissance 3800 g. A l'examen clinique, les fréquences cardiaques et respiratoires sont respectivement à 152/min et 68/min. Un tirage intercostal est présent et l'auscultation des plages pulmonaires révèle un murmure respiratoire diminué au niveau de l'hémithorax gauche. L'abdomen est légèrement excavé et sa palpation ne met pas en évidence d'hépatosplénomégalie. A l'auscultation abdominale, de rares bruits de tonalité normale sont présents. A la radiographie du thorax, un déplacement du médiastin vers la droite et une zone hyperclaire dans l'hémithorax gauche sont notés.

Quel est le diagnostic le plus vraisemblable?

1. une sténose hypertrophique du pylore
2. une hernie hiatale
3. une fistule trachéo-oesophagienne
4. une maladie à membranes hyalines
5. une hernie diaphragmatique

Un garçon de 6 ans consulte pour un rash prurigineux de plus de 2 semaines. Le rash augmente et s'aggrave la nuit. Il ne présente pas d'antécédents de maladies cutanées. L'examen physique révèle de nombreuses papules érythémateuses de 2mm de diamètre localisées entre les doigts, dans les plis cutanés, sous les aisselles, à la ceinture, sur le gland et le scrotum.

Quel traitement faut-il prescrire?

- A. Immunoglobulines (IVIg)
- B. Bethamésone topique
- C. Flucloxaciline (Floxapen)
- D. Permethrine
- E. Dimétindène (Fenistil)

Vous êtes appelé à la maternité pour examiner un nouveau-né. Une fois déshabillé, vous observez un discret ictère. Le nouveau-né ne présente pas de détresse respiratoire et a un bon cri. L'auscultation cardio-pulmonaire est physiologique et le reste de l'examen est sans particularité. L'anamnèse obtenue auprès de la mère semble sans particularité excepté un manque de suivi prénatal. La maman a tout de même eu des sérologies syphilis (négative) et rubéole (immune) et il n'y a pas d'incompatibilité de groupe sanguin. En posant plus de questions à la mère elle admet avoir consommé des drogues par le passé.

Quelle est la condition ci-dessous pour laquelle ce nouveau-né est à risque?

1. Fente palatine
2. Hépatite B
3. Maladie de Niemann-Pick
4. Neuroblastome
5. Malformation rénale

Chez un garçon de 14 ans on trouve une fièvre et une amygdalite caractérisée par la présence de membranes gris-blanchâtres, qu'on peut facilement détacher. Il a des lymphadénopathies généralisées, un exanthème maculo-papulaire, une augmentation des lymphocytes et monocytes dans la formule sanguine.

Quel est le diagnostic le plus probable?

1. une leucémie aiguë
2. une infection à VIH
3. une diphtérie
4. une scarlatine
5. une mononucléose infectieuse

Une adolescente de 13 ans se présente à votre consultation avec ses parents. Ceux-ci sont inquiets en raison de sa « mauvaise posture ». A l'examen clinique, elle a une asymétrie des épaules, des hanches et une gibbosité apparaît quand elle se penche en avant. Le reste de l'examen clinique est normal.

Les affirmations suivantes concernant la pathologie que présente cette adolescente sont vraies à l'exception de:

1. Elle est idiopathique dans la majorité de cas
2. Elle est plus fréquente à l'âge de l'adolescence
3. Elle est typiquement accompagnée de douleurs et d'une raideur
4. Elle peut être associée à la neurofibromatose, le syndrome de Marfan et à la mucopolysaccharidose

Une fillette se présente à votre consultation pour son contrôle des 6 ans. Pendant votre examen clinique, vous mettez en évidence un souffle systolique à l'auscultation cardiaque.

Lesquelles de ces propositions nécessitent une investigation plus poussée ?

1. Un thrill à la palpation
2. Une disparition du souffle en position assise
3. Un souffle diastolique doux associé
4. Une dyspnée à l'exercice

La mère d'un garçon de 18 mois vous consulte en urgence. Il y a 2 jours, après une réprimande banale, le garçon a paru très contrarié, il s'est mis à pleurer, a fait une véritable crise, il en a perdu le souffle et son visage est devenu tout bleu. Cela a duré environ 1 à 2 minutes. Ce matin dans des circonstances analogues, après s'être mis dans une grande colère, il a fait un épisode identique, mais a perdu connaissance pendant un temps que la maman n'arrive pas à préciser, probablement quelques minutes, sa figure était de nouveau toute bleue.

Quelle est l'attitude correcte du médecin?

1. pratiquer un électroencéphalogramme en urgence
2. pratiquer un ECG et organiser une échographie cardiaque.
3. penser à un trouble du rythme cardiaque
4. penser à une épilepsie et envisager de la traiter
5. rassurer la famille en expliquant la nature et le caractère bénin de ces épisodes